

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), kişinin kontrol etmekte zorlandığı, tekrarlayan ve rahatsız edici düşünce, dürtü veya zihinsel imgeler ile bunlara karşı geliştirdiği tekrarlayan davranışlar ya da zihinsel eylemlerle karakterize, kronik bir ruhsal bozukluktur. OKB yalnızca düzenli olmayı sevmek veya bir şeye fazla önem vermek değildir. Asıl sorun, kişinin istemediği düşüncelerin tekrar tekrar ortaya çıkması ve bu düşüncelerin oluşturduğu kaygı, korku, tiksinti veya şüpheyi azaltmak için kendisini belirli davranışları yapmaya zorlanmış hissetmesidir. Bu döngü zamanla kişinin günlük yaşamını, okulunu, işini ve ilişkilerini önemli ölçüde etkileyebilir.

OKB'deki obsesyonlar (takıntılar), kişinin istemediği hâlde zihnine gelen ve yoğun sıkıntı oluşturan düşünce, dürtü veya imgelerdir. En sık görülenler; mikrop veya kirlenme korkusu, kendisine ya da başkasına zarar verme korkusu, bir olaydan sorumlu olma endişesi, hata yapma korkusu, simetri ve düzen ihtiyacı, istenmeyen cinsel düşünceler ile dini veya ahlaki konulardaki yoğun kaygılardır. Bunun yanında ilişkilere, kimliğe, geçmişte yaşanmış olaylara veya varoluşsal konulara yönelik takıntılar da görülebilir. Bu düşünceler çoğunlukla kişinin değerleri ve istekleriyle uyumsuz; yani ego-distoniktir. Kişi bu düşüncelere sahip olmak istemez ve çoğu zaman bunların aşırı veya mantıksız olduğunu fark eder.

Kompulsiyonlar (zorlayıcı davranışlar) ise obsesyonların oluşturduğu sıkıntıyı azaltmak veya korkulan bir durumun gerçekleşmesini önlemek amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Aşırı el yıkama ve temizlik, kapı veya ocağı tekrar tekrar kontrol etme, eşyaları belirli bir düzende yerleştirme, sayma, kelimeleri zihinde tekrarlama, güvence isteme ve olayları zihinsel olarak tekrar tekrar gözden geçirme bunlara örnektir. Kaçınma davranışları da bu döngünün bir parçası olabilir. Kompulsiyon kişiye kalıcı bir çözüm sağlamaz; genellikle yalnızca kısa süreli bir rahatlama sağlar. Bu rahatlamanın ardından obsesyon yeniden ortaya çıkar ve kişi tekrar kompulsiyona yönelir. Böylece obsesyon → kaygı/sıkıntı → kompulsiyon → geçici rahatlama → yeniden obsesyon şeklinde bir döngü oluşur.

Burada önemli olan, her tekrarlayan düşünce veya davranışın OKB anlamına gelmemesidir. İnsanlar zaman zaman hastalanmaktan, hata yapmaktan veya sevdiklerinin başına kötü bir şey gelmesinden endişe edebilir; bazı davranışlarını da tekrar tekrar kontrol edebilir. OKB'de ise bu düşünce ve davranışlar çok daha yoğun ve sürekli. Genellikle günde bir saatten fazla zaman alır, kişide belirgin sıkıntıya neden olur veya günlük yaşamın önemli alanlarını aksatır. Kişi çoğu zaman davranış yapmak istemediği hâlde kendisini yapmak zorunda hisseder. Bu nedenle OKB'deki kompulsiyonlar, kişinin gerçekten sevdiği veya tercih ettiği alışkanlıklardan farklıdır.

OKB belirtileri çocukluk, ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde başlayabilir. Belirtiler zaman içinde değişebilir; bazı dönemlerde azalırken stresli zamanlarda belirgin şekilde kötüleşebilir. Özellikle çocuklarda kişi davranışlarının olağandışı olduğunu fark etmeyebilir ve ritüellerini gerçekleştirmezse kötü bir şey olacağından korkabilir. Bu nedenle belirtilerin ebeveynler veya öğretmenler tarafından fark edilmesi önemli olabilir. OKB'nin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte genetik yatkınlık, beyin bazı bölgeleri ve ağlarındaki farklılıklar, mizaç özellikleri ve bazı çocukluk travmaları olası risk faktörleri arasında değerlendirilmektedir. OKB'ye tik bozuklukları, Tourette sendromu, depresyon, anksiyete bozuklukları ve bazı diğer ruhsal durumlar eşlik edebilir.

OKB'nin önemli bir özelliği erken fark edilmesinin ve tedavi edilmesinin önemli olmasıdır. Araştırmalar, hastalığın uzun süre tedavisiz kalmasının belirtilerin şiddetlenmesi, başka sorunların eşlik etmesi ve tedaviye yanıtın zorlaşmasıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Buna rağmen damgalanma, belirtilerin yanlış anlaşılması ve kişinin düşüncelerini paylaşmaktan çekinmesi nedeniyle doğru tanı yıllarca gecikebilmektedir. Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde erken değerlendirme; kişinin,

ailesinin ve öğretmenlerinin OKB'yi tanınması ve uygun destek alması açısından önem taşır.

OKB tedavi edilebilir ve tedavinin temelinde psikoterapi ve ilaç tedavisi bulunur. Özellikle bilişsel davranışçı terapisinin bir türü olan Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP), kişinin korktuğu veya obsesyonlarını tetikleyen durumlarla kontrollü biçimde karşılaşmasını ve ardından kompulsif davranışı gerçekleştirmemesini öğrenmesine yardımcı olur. Bunun yanında serotonin sistemini hedefleyen SSRI grubu ilaçlar da kullanılabilir. Bazı kişilerde psikoterapi ve ilaç birlikte uygulanabilir. Tedavilere yeterli yanıt vermeyen şiddetli vakalarda ise beyin stimülasyonu gibi daha ileri yöntemler değerlendirilebilir.

Sonuç olarak OKB, günlük dilde kullanılan “takıntılı olmak” ifadesinden çok daha ciddi ve kişinin yaşamını etkileyebilen bir bozukluktur. Hastalığın temelinde yalnızca istenmeyen düşünceler değil, bu düşüncelerin oluşturduğu sıkıntıyı azaltmak için kişinin kendisini tekrarlayan davranışlara veya zihinsel ritüellere yönelmiş hissetmesi vardır. Bu döngünün erken fark edilmesi, doğru değerlendirme ve uygun tedaviyle kişinin yaşamını yeniden kontrol altına alması mümkün olabilir.

Kaynaklar:

- 1) National Institute of Mental Health. (2023). *Obsessive-compulsive disorder: When unwanted thoughts or repetitive behaviors take over*. <https://www.nimh.nih.gov/health/publications/obsessive-compulsive-disorder-when-unwanted-thoughts-take-over>
- 2) Greenberg, W. M. (2024, March 11). *Obsessive-compulsive disorder (OCD)*. Medscape. <https://emedicine.medscape.com/article/1934139-overview>
- 3) International OCD Foundation. (n.d.). *What is obsessive compulsive disorder (OCD)?* <https://iocdf.org/about-ocd/>
- 4) Fontenelle LF, Nicolini H, Brakoulias V. Early intervention in obsessive-compulsive disorder: From theory to practice. *Compr Psychiatry*. 2022 Nov;119:152353. doi: 10.1016/j.comppsy.2022.152353. Epub 2022 Oct 25. PMID: 36341748.

Yayın Tarihi: Ağustos 2026

Sorumlu Yazar: Ali Bocakkıtay/ Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi